

12 - 10- Les troubles psychosomatiques - Pr. ADALI

(0:00 - 0:35)

Est-ce que c'est clair ? D'accord, dans les troubles psychosomatiques, excusez-moi. Voilà, si vous vous rappelez, le trouble psychosomatique, c'est par opposition à l'hystérie. On va toujours faire, au cours de cette présentation, on va toujours faire comparaison entre troubles psychosomatiques et hystérie.

(0:35 - 1:09)

Je vous explique dès maintenant la différence entre les deux. Hystérie et troubles psychosomatiques sont deux pathologies où la dimension psychologique est prépondérante, où il y a une intrication entre la dimension psychologique et la dimension somatique. Qu'est-ce que c'est que l'hystérie ? On peut résumer l'hystérie en une phrase.

(1:10 - 1:36)

On peut résumer l'hystérie. C'est une conversion d'une souffrance psychique en un symptôme physique. Quand tu fais l'examen clinique de ton patient, il est comment ? Il est normal.

(1:37 - 2:08)

Idem pour les troubles psychosomatiques. Dans les troubles psychosomatiques, le stress psychologique va influencer le somatique. Sauf que dans les troubles psychosomatiques, il y a de réelles pathologies organiques qui sont influencées négativement ou compliquées par la dimension psychologique.

(2:09 - 2:24)

Il y a des atteintes objectivables d'un organe ou de son fonctionnement. L'examen clinique est anormal. Les examens paracliniques aussi sont anormaux.

(2:24 - 2:41)

Il y a de réelles pathologies somatiques. La dimension psychologique serait prépondérante dans la survenue des troubles psychosomatiques, dans leur évolution. Ce n'est pas le stress psychologique qui a causé la maladie.

(2:42 - 2:57)

Donnez-moi un exemple d'une pathologie psychosomatique, en fonction de ce que je viens de vous expliquer. Non. C'est qu'il s'y fonctionnait.

(2:57 - 3:11)

Mais qu'est-ce qu'il y fonctionnait ? C'est directement l'hystérie. Fonctionnelle, ça veut dire que c'est des symptômes. L'examen clinique est normal.

(3:20 - 4:07)

Les douleurs qu'elles ont. Pardon ? L'asthme, le diabète, l'HTA, le psoriasis. Oui ou non ? Oui ou non ? Qui est d'accord ? Diabète maintenant, diabète.

(4:09 - 4:30)

Diabète, oui ou non ? Est-ce que ça correspond à la définition ? Qui est en train de parler ? Levez la main s'il vous plaît, je ne vois pas. Oui, mademoiselle. Oui.

(4:31 - 4:42)

Donc, la glycémie augmente, c'est-à-dire que l'examen clinique est anormal. L'examen pas clinique. Il y a une pathologie qui s'appelle le diabète, qui est une pathologie somatique, qui est influencée par le stress psychologique.

(4:42 - 4:48)

Oui ou non ? L'HTA. Oui ou non ? L'asthme. L'asthme a tué.

(4:48 - 5:24)

Le stress a tué une personne. Je vous le dis, j'ai été jurée dans le concours de Residana, il n'y a pas très longtemps. On avait corrigé les copies et le jour de l'oral, tout le monde était présent, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont réussi l'écrit ont été présentes à l'oral, sauf une personne, c'était une jeune fille, c'était une femme, une jeune fille, la Rahman.

(5:25 - 5:44)

Donc, on faisait la paix, on s'est dit, cette personne-là n'est pas venue, il y a un membre du jury qui nous a dit, Miskina Mazet la Rahman. Quoi les décédés ? Les décédés entre l'écrit et l'oral. Elle a fait une crise d'asthme aiguë, hospitalisée en réanimation, décédée.

(5:46 - 6:05)

Je ne sais pas si ça fait rire ou là ça fait de la peine, c'est qu'elle a eu de très bonnes notes, l'écrit. Elle a réussi l'écrit avec de très bonnes notes. Et elle est décédée, et elle était connue asthmatique, mal stabilisée, mais bon, elle était en vie.

(6:06 - 6:34)

Et à cause du stress de l'examen, ce qui était un stress, un grand stress du Residana, elle est

décédée. Donc l'asthme aussi, c'est une pathologie typiquement psychosomatique, la majorité des pathologies dermatologiques. L'exemple le plus typique que connaissent tous les dermatologues, c'est le psoriasis, qui est une pathologie qui est influencée par les facteurs de stress.

(6:35 - 7:05)

Le HIV, oui ou non ? Oui ou non ? Je vous dis pour le HIV, pourquoi c'est une pathologie qui est influencée aussi par le stress. Il y a des patients qui sont des porteurs sains et que suite à un prélèvement sanguin de routine, ils peuvent, on peut détecter chez eux le HIV. Ils étaient des porteurs sains depuis une dizaine d'années.

(7:06 - 7:24)

Une fois on leur annonce le diagnostic, ils passent, ils sautent brutalement vers le stade d'une maladie assez grave. Le sida, est lèche. C'est à cause du prélèvement, c'est à cause de l'annonce d'une maladie assez grave.

(7:25 - 8:02)

Le cancer aussi, c'est une pathologie qui est psychosomatique. Est-ce que vous comprenez la différence maintenant entre l'hystérie et les pathologies psychosomatiques ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que c'est clair ? Une fois installé, on va toujours prendre l'exemple du diabète parce que c'est l'exemple le plus simple que vous pouvez assimiler facilement. Une fois installé, le trouble physique va évoluer de son propre compte, c'est-à-dire indépendamment du facteur de stress qui était à son origine.

(8:08 - 8:55)

Contrairement, rappelez-vous, quand on a parlé de l'hystérie, c'était quel type de musculature qui était atteinte ? Volontaire ou involontaire ? Est-ce que c'est les organes d'un ? Pardon ? Est-ce que c'est ce qui permet d'aller vers l'autre ? Dans les troubles psychosomatiques, c'est les musculatures lisses et les viscères qui sont atteints. D'accord ? On a vu, ne pas confondre. Le choix de l'organe qui est atteint n'a aucune signification dans les troubles psychosomatiques, contrairement à l'hystérie.

(8:56 - 9:08)

On avait vu qu'il y a une signification inconsciente de l'organe qui est touché. La cécité, c'est pour ne pas voir l'autre. L'éniphlégie, c'est pour ne pas aller vers l'autre.

(9:09 - 9:26)

D'accord ? Il y a une liste de pathologies psychosomatiques. Les pathologies cardiovasculaires

aussi. L'HTLM, toutes les pathologies dermatologiques.

(9:26 - 9:35)

Les maladies de système aussi. Le lupus, l'APR, etc. Les maladies infectieuses, on en avait parlé.

(9:37 - 9:53)

Certaines pathologies endocriniennes, notamment le diabète, les hypoparas. J'ai mis une liste. Bien sûr, l'approche psychanalytique ou la cognitive ou comportementale, je ne poserai pas des questions sur ça.

(9:55 - 10:25)

Gardez surtout en tête que, surtout la notion d'événements de vie, parce que c'est ce qui permet d'expliquer, plutôt la survenue du déclenchement de la maladie. Mais surtout garder en tête que, c'est par cette personne-là que ce qui suit un événement de vie, par exemple majeur, a développé un diabète. Elle était prédisposée biologiquement à devenir diabétique.

(10:26 - 10:49)

Cet événement majeur n'a fait que précipiter l'apparition du diabète. Ce n'est pas le facteur causal du diabète, mais le facteur précipitant. Peut-être que s'il n'y avait pas cet événement de vie stressant, cette personne pouvait développer son diabète 10 ans après, ou 2 ans après, 5 ans après.

(10:49 - 11:13)

Cela n'a fait que précipiter l'apparition du diabète. Dans la notion d'événements de vie, c'est important de mentionner que il y a des événements de vie majeurs, des traumatismes majeurs, traumatismes de guerre, les AVP, les agressions. Il y a aussi ce qu'on appelle les événements de vie mineurs.

(11:13 - 11:46)

L'accumulation de plusieurs événements de vie mineurs, de plusieurs stress mineurs, peut à la fin entraîner le même impact qu'un événement de vie majeur. Le cumul des tracas de la vie quotidienne peut entraîner une situation qui peut être en intensité similaire à un événement de vie majeur. Je ne poserai pas de questions sur cela.

(11:51 - 12:20)

Premier diagnostic... Excusez-moi. Premier diagnostic différentiel... Premier diagnostic différentiel avec les troubles psychosomatiques ou le trouble de conversion. Vous comprenez pourquoi ?

Vous comprenez pourquoi ? L'hypochondrie.

(12:20 - 12:33)

Je n'ai l'hypochondrie. C'est la crainte du noir. J'ai des soucis par rapport à la santé.

(12:33 - 12:47)

C'est la crainte d'avoir... C'est le délire hypochondriaque. Le délire, c'est-à-dire une conviction délirante qu'on a une maladie grave. L'hypochondrie, c'est une crainte.

(12:48 - 13:16)

Ce n'est pas le degré du délire. C'est une crainte d'avoir une maladie grave ou sérieuse. Mais qu'est-ce qui caractérise aussi l'hypochondrie ? Pardon ? Oui, plutôt, il n'est pas rassuré par les examens complémentaires.

(13:17 - 13:32)

Vous avez un patient qui est sûr qu'il a une maladie cancéreuse grave. Vous avez fait tout le bilan de syndrome paranéoplasique, les examens complémentaires, vous avez fait un scanner. Tout est normal.

(13:32 - 13:57)

Que va dire le patient ? Est-ce qu'il va être rassuré ? Qui va être rassuré ? Une personne qui a le TAG, trouble de l'anxiété généralisée. Oui ou non ? Une personne qui a un trouble de l'anxiété généralisée, il suffit qu'il fasse son bilan et qu'il trouve que c'est normal. Il peut demander deux avis.

(13:57 - 14:25)

Un patient qui a un TAG, il peut demander un deuxième avis. Si les deux médecins, par exemple, sont d'accord qu'il n'a rien, qu'il est OK, il va être rassuré. Par contre, une personne hypochondriaque, qu'est-ce qu'elle va dire ? Pardon ? Faux négatif ou là ? Non, même pas.

(14:25 - 14:37)

Elle va dire que j'ai une pathologie grave que même la science n'a pas encore découverte. Donc c'est inaccessible à la réassurance. D'accord.

(14:39 - 14:48)

Oui. Touche les deux sexes. Elle a le trouble douloureux.

(14:50 - 15:09)

C'est une pathologie douloureuse. C'est un trouble qui est cité dans le DSM 5, DSM 4 et 5 aussi. C'est une pathologie douloureuse qui entraîne une souffrance, une altération sociale, professionnelle ou d'autres domaines.

(15:09 - 15:35)

Il est... Il est... Certains auteurs l'assimilent à la fibromyalgie que vous avez citée tout à l'heure. C'est un syndrome douloureux de localisation différente, quelle que soit, qui dépend de chaque personne. La localisation de la douleur n'a aucune signification chez la personne.

(15:35 - 15:54)

Et l'examen clinique, il est normal. La peur d'une dysmorphophobie, d'une dysmorphie corporelle ou d'une dysmorphophobie. La dysmorphophobie ou la peur d'une dysmorphie corporelle.

(15:55 - 16:11)

Connaissez-vous? Oui. Un défaut physique. Dysmorpho, morpho ça vient de morphologie, dys c'est anomalie.

(16:12 - 16:38)

Donc c'est la conviction qu'on a un défaut, surtout au niveau du visage, un défaut physique, surtout au niveau du visage. La dysmorphophobie, c'est un trouble qui peut être, qui généralement précède une pathologie psychotique, notamment la schizophrénie. J'ai un exemple en tête d'un patient qu'on avait, un jeune patient qu'on avait hospitalisé.

(16:42 - 17:07)

Motifs d'hospitalisation, agitation psychomotrice et agression de son médecin traitant dans une clinique. Il était hospitalisé dans une clinique, il s'est agité, il a agressé son médecin traitant. Donc ils ont appelé la police, ils l'ont ramené à l'hôpital, patient en extrême agitation psychomotrice.

(17:08 - 17:31)

D'accord? Mon entretien avec le malade a montré que c'était un jeune homme qui était convaincu que sa lèvre, je ne m'en rappelle pas, était déformée. Malgré que il n'y avait pas d'anomalie. La forme de sa bouche était tout à fait normale.

(17:32 - 17:54)

C'est un patient qui a poussé sa famille, c'est une famille assez aisée, à aller voir tous les plasticiens, les chirurgiens plasticiens, les meilleurs pour qu'il se fasse opérer. Tous les chirurgiens étaient d'accord sur le fait qu'il n'a pas de malformation. Donc ils ont refusé de

l'opérer.

(17:56 - 18:23)

Il a vu un médecin X qui l'avait convaincu qu'il pourra qu'il va lui faire une injection d'un traitement X qui va l'améliorer. Donc il l'a hospitalisé dans une clinique et il lui a injecté des neuroleptiques parce qu'il savait qu'il avait une pathologie psychiatrique. Le souci c'est que le lendemain quand le malade s'est réveillé, il a regardé dans le miroir et tout était normal.

(18:25 - 18:36)

C'était encore déformé pour lui. Quand son médecin traitant est venu le voir, il a cassé la chambre. Il le mérite, il le mérite ce médecin traitant.

(18:37 - 18:58)

Ce qu'il a menti au patient. Oui, tu veux lui prescrire des neuroleptiques, tu lui dis que c'est dans ta tête, tu lui expliques ce qu'il a, mais ne lui dis pas que c'est l'injection qui va améliorer ta malformation. Oui, tu as une malformation qui nécessite une injection.

(18:59 - 19:18)

Et il l'a agressé physiquement. Après, avec l'évolution, avec l'anamnèse, il y avait certains éléments déficitaires de l'isolement, prise de toxiques, et l'évolution, c'était vers une schizophrénie. C'était un jeune garçon de 16 ans, 17 ans, si ma mémoire est bonne.

(19:18 - 19:59)

D'accord? La conduite à tenir. À votre avis, quelle est la conduite à tenir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la pathologie psychosomatique? En tant que médecin généraliste, quel est votre travail? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la pathologie psychosomatique? Pardon? Oui, dans la pathologie psychosomatique, tu as déjà ton diagnostic. Tu as déjà un patient qui vient te voir parce qu'il est diabétique.

(20:00 - 20:14)

Donc, tu as déjà un diagnostic somatique. C'est clair. Qu'est-ce que tu vas faire? Pardon? Oui, faire de l'éducation au patient.

(20:15 - 20:35)

Lui expliquer c'est quoi une pathologie psychosomatique, c'est quoi l'influence du stress, des événements de vie stressants sur sa pathologie? Pardon? Oui, c'est clair. Mais je parle de la dimension psychosomatique. Là, tu me parles de la dimension somatique.

(20:35 - 20:44)

C'est normal, oui. Je suis d'accord avec toi. La dimension psychosomatique, votre collègue a dit qu'il faut éduquer le patient sur le stress et les pathologies psychosomatiques.

(20:45 - 20:51)

Oui. Je n'ai pas les méthodes de copine. Je ne suis pas copine.

(20:51 - 21:05)

Je n'ai pas les méthodes de copine. Je n'ai pas les méthodes de copine. Comment s'adapter? Comment accompagner? Comment s'adapter à sa maladie? Les méthodes de copine, oui.

(21:07 - 21:40)

Les méthodes les plus simples que vous connaissez, je n'en ai pas. Activité régulière, oui ou non? Mais avant les méthodes de copine, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Ça, on l'a vu dans l'hystérie. Pardon? En tant que médecin traitant, comment vous allez faire? Vous devez, tu as raison, les chercher d'abord.

(21:42 - 22:08)

Quels sont les facteurs de stress qu'il a? Oui. Parce que qu'est-ce qui arrive? Diabète. Ce qui nous arrive toujours avec le service, s'il vous plaît, avec les endocrinologues, c'est qu'ils nous envoient des patients qui sont bien observants du traitement, c'est-à-dire qui diront l'insuline régulièrement, ils font leur régime régulièrement, correctement et pourtant, leurs chiffres glycémiques ne s'améliorent pas.

(22:10 - 22:29)

Donc, ils se disent que non, c'est pas normal. Avec ces chiffres-là, avec un patient aussi compliant et les chiffres sont toujours élevés. Donc, c'est des patients où il y a une composante psychologique qui influence négativement le diabète.

(22:29 - 22:56)

J'ai une patiente, j'avais une étudiante en médecine qui faisait des crises d'asthme sévères. Quand je dis sévères, ça nécessitait une hospitalisation parfois en réanimation. Donc, c'est une étudiante d'ailleurs qui est venue me voir pour un autre membre de sa famille pour une autre pathologie.

(22:59 - 23:19)

Et elle me dit qu'elle a un asthme qui est mal équilibré et que sa maman aussi était médecin.

Donc, ils l'ont ramenée en France et ils ont fait tout le bilan de tous les allergènes et les lichénines dans le monde. Ils n'ont rien trouvé.

(23:20 - 23:43)

C'était en fait une étudiante qui avait un facteur de stress familial, centré dans les détails et qui était déprimée. Une fois mise son antidépresseur, amélioration spectaculaire de ses crises d'asthme, résistance réfractaire. C'était une patiente qui prenait bien son traitement contre l'asthme.

(23:51 - 24:12)

Tout ce qui pouvait entraîner une crise d'asthme sévère chez elle, ils l'ont éradiquée et pourtant, c'était une étudiante qui ne s'améliorait pas. Son traitement antidépresseur, bonne amélioration de ses crises d'asthme. Donc déjà, chercher les facteurs de stress chez le patient.

(24:14 - 24:24)

Vous avez trouvé les facteurs de stress. On en a parlé. On a parlé de ça avec l'hystérie.

(24:24 - 24:42)

C'est presque les mêmes principes de traitement, de prise en charge. L'empathie. Très bien, tu as raison.

(24:42 - 24:49)

L'empathie. Aider le patient à parler de sa souffrance. Reconnaître sa souffrance.

(24:50 - 25:06)

Ne pas culpabiliser le patient parce qu'il fait des chiffres glycémiques élevés. Ne pas le culpabiliser à cause de ça. L'empathie.

Parler avec le patient. Faire une psychothérapie de soutien. Ça va aider énormément le trouble.

(25:06 - 25:29)

Ne pas contester la légitimité du trouble. Il ne faut même pas le rassurer. Rassurer le patient.

Non, ce que tu ressens, c'est réel. Chercher plutôt une atténuation des symptômes plutôt qu'une guérison. Écouter attentivement.

(25:32 - 25:42)

C'est surtout ça. Il s'agit de prendre en soin le patient et de le renoncer à le guérir. C'est les

mêmes principes de traitement de l'hystérie.

(25:49 - 26:13)

Tout ce qui est thérapie corporelle. Est-ce que vous avez des questions concernant les troubles psychosomatiques ? Je ne pose pas de questions sur les diagnostics différentiels. Pour la neurobiologie, la psychopathologie, je ne pose pas de questions.

(26:14 - 26:19)

Diagnostic différentiel, oui. En tout cas, ma chiffre des troubles psychosomatiques. Je peux le poser.

(26:19 - 26:45)

Pour des pathologies où c'est assez clair pour un étudiant de cinquième année. La psychose du postpartum, je pourrais poser une question par rapport au fait d'éliminer un problème organique en premier. Mais je ne vais pas vous poser une question concernant quels sont les diagnostics différentiels d'un trouble psychosomatique.

(26:45 - 27:11)

Ça, je ne ferai pas. La psychopathologie, je ne vous demanderai pas de me citer quelles sont les théories explicatives du trouble psychosomatique ou de la schizophrénie ou de la de l'hystérie. Ça, ça va vous aider à comprendre si vous l'apprenez ou si vous le comprenez.

(27:11 - 27:21)

Ça va vous aider plutôt à assimiler et à apprendre les symptômes. À comprendre les symptômes. Mais je ne vais pas poser de question là-dessus.

(27:22 - 27:58)

Surtout pour le trouble psychosomatique, je ne pose pas de question sur les diagnostics différentiels. Donc il nous reste deux chapitres qu'on pourrait terminer aujourd'hui. Et on pourrait, s'il vous plaît, on pourrait faire et on pourrait laisser 30 minutes aux questions que vous avez.